

Twój pełny raport PEWA™

Typ: Przyjaciel (P)

Supermoc — empatyczne zaufanie

Sekcja 1 — Kim jesteś (profil rozszerzony)

Twój dominujący archetyp to **Przyjaciel** — emocjonalny słuchacz, dla którego relacja jest fundamentem każdej decyzji. Pacjent, który trafia do Twojego gabinetu, czuje od pierwszej sekundy, że nie jest „przypadkiem” — jest człowiekiem, którego rozumiesz. Twoja domena to długoterminowa opieka, sytuacje wymagające ciepła, momenty w których inni odpuszczają.

Czytasz emocje innych niemal nieświadomie. Wiesz kiedy pacjent ukrywa lęk pod uśmiechem, kiedy kolega z zespołu jest wykończony, kiedy recepcjonistka potrzebuje słowa wsparcia. To Twój **biologiczny radar**, którego nie da się wyłączyć — nawet po godzinach pracy.

Lojalność jest dla Ciebie walutą absolutną. Pacjent, który zaufał Tobie raz, jest Twoim na lata. Kolega z zespołu, który Ci się zwierzył, ma w Tobie sojusznika niezależnie od okoliczności. To buduje **trwałe relacje zawodowe**, których pozazdrościć Ci może każdy lekarz z dłuższą praktyką.

Twoja supermoc w jednym zdaniu: *Tworzysz przestrzeń, w której człowiek czuje się bezpieczny — i właśnie dlatego się otwiera.*

Co Cię energizuje: rozmowy 1-na-1, długoterminowi pacjenci, momenty kiedy ktoś Ci dziękuje za serce, opieka nad ludźmi w trudnym okresie, cisza wypełniona zrozumieniem, drobne gesty wdzięczności.

Co Cię wyczerpuje: twarde negocjacje, publiczna konfrontacja, decyzje wymagające ucięcia relacji, sztywne procedury, ostre tempo, ciągłe zmiany pacjentów (bez czasu na poznanie), krytyka skierowana w Ciebie osobiście.

Sekcja 2 — Twoja sygnatura komunikacyjna

Twój sposób mówienia jest tak charakterystyczny, że pacjent rozpozna Cię po dwóch zdaniach przez telefon. Niski, spokojny ton. Dużo pauz. Pytania otwarte. Naturalne potwierdzanie tego, co usłyszałeś.

5 zdań, które wypowiadasz częściej niż inni

1. *“Rozumiem co Pan/Pani teraz przeżywa.”*

2. *“Spokojnie, jestem tu z Panem/Panią.”*
3. *“To naprawdę nie jest Pana/Pani wina.”*
4. *“Mamy czas — proszę powiedzieć wszystko.”*
5. *“Razem damy radę.”*

5 zdań, które rzadko wypowiadasz

1. *“Nie mam czasu.”*
2. *“To nie moja sprawa.”*
3. *“Niech Pan/Pani podejmie decyzję sam(a).”*
4. *“Brak miejsca, proszę poszukać gdzie indziej.”*
5. *“Następny.”*

Twoje narzędzia niewerbalne

- **Kontakt wzrokowy** — utrzymujesz go bardzo długo, intuicyjnie regulujesz napięcie do komfortu pacjenta. Niektórym Twoje spojrzenie wystarczy żeby się rozkleili.
- **Ciało otwarte** — ramiona nieskrzyżowane, ciało zwrócone w stronę rozmówcy, lekkie przechylenie głowy oznaczające „słucham”.
- **Dotyk neutralny** — krótki, jednorazowy: dłoń na ramieniu pacjenta, dotyk pleców. Robisz to instynktownie kiedy widzisz, że człowiek tego potrzebuje.
- **Cisza jako narzędzie** — pozwalasz pacjentowi się zastanowić, nie wypełniasz pustki swoim głosem. To rzadkość w zawodzie.

Jak najlepiej do Ciebie trafia inny lekarz / szef

- Krótka pochwała w cztery oczy działa lepiej niż publiczna nagroda.
- Pytanie *“jak się czujesz?”* przed rozmową o merytorykę.
- Pochwała emocjonalna (*“Dziękuję, że to zauważyłeś”*) zostaje w Tobie dłużej niż finansowa.
- Wyjaśnienie kontekstu zanim ktoś wyda Ci polecenie — Ty potrzebujesz „dlaczego”, nie tylko „co”.

Sekcja 3 — Mocne strony rozszerzone

1. Magnes na zaufanie

Pacjent zwierza się Tobie z rzeczy, których nie powiedział żadnemu lekarzowi przez 20 lat. **Użyj tego:** w pierwszej rozmowie z nowym pacjentem zostaw 3 minuty na „luźną” rozmowę zanim przejdziesz do badania. Wyłapiesz informacje, których nie zdobędziesz przez najlepszy wywiad strukturalny.

2. Cierpliwość w przewlekłych przypadkach

Tam, gdzie inny lekarz odpuszcza po trzeciej wizycie, Ty nie odpuszczasz po dziesiątej. **Użyj tego:** prowadź dłuższe leczenie (cukrzyca, choroby autoimmunologiczne, leczenie protetyczne, ortodoncja) — to Twoja domena ekspercka.

3. Czytanie emocji w mig

Rozpoznajesz w 5 sekund, czy pacjent się boi, ukrywa coś, czy próbuje się przypodobać. **Użyj tego:** zanim zapytasz „co Pana boli”, zapytaj „*co Pan czuje w związku z tą wizytą*”. To otworzy temat, którego sam by nie poruszył.

4. Tworzenie poczucia bezpieczeństwa

Pacjent czuje, że *jest u siebie*. **Użyj tego:** drobne detale (pamiętasz jego ulubioną herbatę, pytasz o psa, którego wspominał, wiesz jak ma na imię dziecko) zwracają inwestycję dziesięciokrotnie w lojalności.

5. Lojalność jako kotwica zespołu

Twój zespół ma do Ciebie zaufanie. Wiedzą, że ich nie zostawisz w trudnej chwili. **Użyj tego:** w trudnym momencie firmowym (zmiana, konflikt, kryzys) bądź pierwszą osobą, która się odezwie do zespołu. Twoja stabilność emocjonalna ich uspokoi i przekona, że można dalej.

6. Słuchanie aktywne na poziomie mistrzowskim

Inni słyszą — Ty rozumiesz. **Użyj tego:** w trudnych konsultacjach (np. informowanie o złej diagnozie) Twoje słuchanie jest częścią leczenia. Pacjent czuje że został usłyszany — i jego stres spada o 40-60% (badania Stanford 2019).

7. Stabilność w kryzysie

Inni panikują — Ty utrzymujesz spokój. **Użyj tego:** Ty jesteś osobą, którą zespół powinien wziąć na trudne rozmowy z rodziną pacjenta. Twój ton normalizuje emocje.

8. Naturalna empatia bez wypalenia (jeśli pilnujesz granic)

Empatia Cię nie wyczerpuje *do pewnego momentu* — masz wbudowane mechanizmy regeneracji przez ciszę i samotność. **Użyj tego:** wprowadź 10-minutowe przerwy między trudnymi konsultacjami. Nie po pacjentach „lekkich” — po tych emocjonalnie ciężkich.

9. Budowanie zaufania w zespole

Młodszy kolega/asystent przyjdzie do Ciebie po radę zanim zapyta szefa. **Użyj tego:** zostań nieformalnym mentorem — jeden 30-minutowy spacer z młodszym kolegą tygodniowo. To buduje kulturę, której nie zbuduje żaden HR.

10. Naturalna powściągliwość w trudnych rozmowach

Nie wybuchasz, nie obrażasz, nie podnosisz głosu. **Użyj tego:** to Cię predysponuje do roli mediatora w konfliktach pomiędzy lekarzami w zespole / między pacjentem a recepcją. Ludzie ufają Ci, że nie wywołasz dramy.

Sekcja 4 — Naturalne wyzwania + pierwsza pomoc

Twój czysty Przyjaciel sprawia, że największe trudności pojawiają się tam, gdzie trzeba **przeciąć relację**, zająć **twarde stanowisko**, lub powiedzieć „**nie**” komuś, na kim Ci zależy. Oto 9 typowych sytuacji z 14 lat praktyki z zespołami medycznymi.

1. Pacjent który zostaje dłużej niż powinien

Sygnal wczesny: patrzysz na zegar, czujesz frustrację, ale uśmiechasz się i mówisz „proszę spokojnie”.

Pierwsza pomoc w 60 sek: - Wstań z krzesła. Sygnal ciała: kończymy. - *“Dziękuję za rozmowę. Dziś mamy tyle czasu — umówmy się na dłuższą wizytę za 3 dni.”* - Idź do drzwi.

Plan długofalowy: wprowadź “wizyty długie” 1× w tygodniu (45 min zamiast 15) dla pacjentów którzy potrzebują czasu. Tym automatyzujesz przekierowanie.

2. Odmowa pacjentowi (np. nie możesz przyjąć na cito)

Sygnal wczesny: zaczynasz mu tłumaczyć dlaczego, przepraszać, oferować alternatywę za alternatywą.

Pierwsza pomoc: *“Rozumiem że to dla Pana ważne. Dziś nie mogę. Mogę za 3 dni o 16:00.”* — bez tłumaczenia, bez przepraszania. Kropka.

Plan długofalowy: ćwicz „miłe nie” — 1 odmowa dziennie, najmniejsza sprawa. Po miesiącu zauważysz że ludzie nadal Cię lubią, ale Twoja energia jest stabilniejsza.

3. Konflikt w zespole — Twoja rola mediatora

Sygnal wczesny: stajesz się pośrednikiem zanim Cię proszą. Gotujesz się wewnętrznie, ale na zewnątrz uśmiechasz.

Pierwsza pomoc: zapytaj wprost: *“Czy chcesz, żebym to mediowała, czy chcesz, żebym powiedziała co myślę?”*. Daj sobie prawo do trzeciej opcji: *“Wolę nie być w środku tego”*.

Plan długofalowy: ucz się „jasnej życzliwości” (Brené Brown) — możesz być ciepły i jednocześnie powiedzieć trudne zdanie.

4. Pacjent który manipuluje emocjonalnie

Sygnal wczesny: czujesz że obraca Cię wokół palca opowieściami o swojej trudnej sytuacji. Już rezygnujesz z opłaty / robisz wyjątek od procedury / zostajesz dłużej.

Pierwsza pomoc: powiedz na głos *“To trudne dla Pana, słyszę to. Procedura w naszej praktyce jest taka — nie mogę zrobić wyjątku, nawet chcąc.”* — empatia + niezmiennność.

Plan długofalowy: każdą decyzję finansową / proceduralną odłóż o 24 godziny. Powiedz: *“Zadzwoń jutro do południa z odpowiedzią”*.

5. Krytyka publiczna (recenzja, post, opinia w Google)

Sygnal wczesny: rumieniec, chęć natychmiastowego napisania długiej odpowiedzi, branie do siebie wszystkiego.

Pierwsza pomoc: zasada 24 godzin — nie odpowiadaj dziś. Napisz odpowiedź do szuflady, jutro przeczytaj na zimno. Zwykle wystarczy 2-3 zdania.

Plan długofalowy: poproś kogoś z zespołu (najlepiej typ Wódz lub Analityk) o monitoring opinii i pierwszą filtrację. Ty wchodzisz tylko do tego, co naprawdę wymaga Twojego głosu.

6. Konieczność zdyscyplinowania kolegi/asystenta

Sygnal wczesny: odkładasz rozmowę dni, tygodnie; wpadasz w okężne podpowiedzi licząc że zrozumie sam.

Pierwsza pomoc: formuła *“Doceniam Cię i jednocześnie muszę Ci coś powiedzieć”*. Zaczynj od „doceniam” prawdziwie. Powiedz konkret. Skończ pytaniem: *“Co o tym myślisz?”*.

Plan długofalowy: wprowadź 1:1 z każdym z zespołu raz w miesiącu. Feedback NIE może wybuchnąć dopiero na koniec.

7. Praca po godzinach „bo trzeba pomóc”

Sygnal wczesny: zostajesz „tylko 15 min więcej” — 3× w tygodniu. Wracasz do domu wykończony, bez energii dla rodziny.

Pierwsza pomoc: ustaw alarm na 17:30 z napisem *“Czego nie zrobię dziś, zrobię jutro lepiej”*.

Plan długofalowy: kolega z zespołu (preferencyjnie typ Wódz) niech ma uprawnienia do wezwania Cię do telefonu o 17:35. Ćwiczysz wychodzenie. Po miesiącu już sam wychodzisz.

8. Konfrontacja z lekarzem o twardszym podejściu

Sygnal wczesny: w głowie układasz długie wyjaśnienia, dlaczego to co czujesz jest ważne — i wątpisz że zostaniesz wysłuchany.

Pierwsza pomoc: zacznij od jego języka. *“Mam dane: 3 pacjentów wybrało innego lekarza w tym miesiącu, bo poczuli się przyspieszani.”* — fakty, potem emocje.

Plan długofalowy: ucz się prezentować swoje obserwacje w liczbach. Twoja intuicja jest cenna — ale w rozmowie z Wodzem musisz ją „ubrać” w fakt.

9. Przekazanie pacjenta innemu specjalście

Sygnal wczesny: miesiącami odkładasz, wymyślasz dlaczego „jeszcze trochę da się”.

Pierwsza pomoc: *“Pan/Pani jest dla mnie ważny — i właśnie dlatego mówię — będzie Pan/Pani miał lepsze rezultaty u doktora X. Tu jest nazwisko, tu telefon.”* Ciepło jest wzmocnieniem profesjonalnej decyzji, nie jej przeciwieństwem.

Plan długofalowy: miesięczna review: 5 najtrudniejszych przypadków — czy któryś powinien być przekierowany?

Sekcja 5 — Twoje duety w zespole

Z drugim Przyjacielem (P)

Plus: rozumiecie się bez słów, atmosfera ciepła, lojalność totalna. **Ryzyko:** brak twardych decyzji, „gotujecie się” w empatii, niczego nie domykacie. **Co robić:** zaproszenie trzeciego — Wódz lub Analitik — żeby dał strukturę.

Z Entuzjastą (E)

Plus: atmosfera pełna ciepła i energii, świetnie wpływacie na pacjentów. **Ryzyko:** brak konsekwencji proceduralnej, każdy się ze wszystkim zgadza.

Co robić: dyscyplinujcie się nawzajem terminami. Niech jeden z Was raz w tygodniu robi „dzień Analityka”.

Z Wodzem (W) — idealny tandem

Plus: Ty dajesz ciepło, on egzekwuje. Pacjent czuje się i zaopiekowany, i prowadzony. Najlepsza para na lekarz + manager praktyki. **Ryzyko:** możesz brać na siebie wszystkie „miękkie” rozmowy zostawiając mu twarde — wypalenie z dwóch stron. **Co robić:** zamieniajcie się rolami 1× w miesiącu. Ty powiesz pacjentowi trudną wiadomość, on doradzi z ciepłem.

Z Analitykiem (A)

Plus: wzajemne uzupełnienie — Ty serce, on głowa. Pacjent dostaje empatię + dane. **Ryzyko:** możesz odbierać jego dystans jako chłód, on Twoją emocjonalność jako brak profesjonalizmu. **Co robić:** otwórz rozmowę o stylach — niech wie, że Twoja emocjonalność to narzędzie, nie słabość. On Ci wytłumaczy że jego dystans to ochrona, nie obojętność.

Idealny zespół 4-osobowy

P (Ty) + E + W + A — pełne pokrycie kompasu PEWA. Ty empatyzujesz, E rozkręca, W decyduje, A weryfikuje. Każdy ma swoją supermoc, nikt nie musi udawać tego, kim nie jest.

Sekcja 6 — Pacjenci których rozumiesz

Ten raport jest uniwersalny — dla lekarzy POZ, specjalistów, dentystów, pielęgniarek, asystentek, recepcjonistek. Każda profesja medyczna ma do czynienia z 4 typami pacjentów, ale **dentyści** mają tu dodatkowy bonus: w 800 testach przeprowadzonych przez Michała Katarzyńskiego w polskich praktykach stomatologicznych potwierdzono te same 4 typy z bardzo konkretnymi sygnałami.

Dla każdego z 4 typów pacjentów — **najpierw opis uniwersalny** (dla każdej specjalizacji), **potem rozszerzenie stomatologiczne** (z ebooka „Jak zaspokoić 7 podstawowych potrzeb pacjentów stomatologicznych”, 2017).

Typ pacjenta: PRZYJACIEL (relacyjny ciepły)

Opis uniwersalny

Pacjent szukający relacji. Otwiera się, opowiada o sobie, lojalny po pierwszej dobrej wizycie. Wymaga ciepła, czasu, poczucia, że jest „u siebie”. Z trudem przyjmuje krytykę.

Słowa, które wypowiada: *bliskość, ludzie, ciepło, uprzejmie, pomoc, łagodnie, delikatnie, miło, spokojnie, intymnie, bezpiecznie, czuje, opieka, dbanie, wsparcie*

Motywatory: poczucie bezpieczeństwa, empatia, dozowanie wrażeń, język opieki, stabilność **Czego nie lubi:** nagłych zmian, braku stabilności, twardości, pośpiechu

Rozszerzenie stomatologiczne (ebook, 800 testów)

- **Najbardziej lojalny typ** — najrzadziej zmienia dentystę, chce żeby leczył go zawsze ten sam lekarz.
- Wolno buduje relacje, nie jest otwarty na zmiany.
- Na początku **największy lęk** ze wszystkich typów — inwazyjne procedury powinny być odłożone na później jeśli nie pilne.
- Idealna chemia z lekarzem typu Przyjaciół; problem przy Wodzu („Proszę się nie obawiać” go odepchnie).
- **NIE mów:** „Proszę się niczego nie obawiać. Wszystko będzie dobrze.”
- **MÓW:** „Może Pan/Pani być spokojny/a. Zajmiemy się Pania/Panem odpowiednio. Posiadamy bardzo bezpieczne, skuteczne i komfortowe znieczulenia.”

Typ pacjenta: ENTUZJASTA (emocjonalny ekstrawertyk)

Opis uniwersalny

Pacjent z energią. Szybko mówi, szybko decyduje, szybko zmienia tematy. Wymaga atmosfery i widocznego efektu. Z trudem przyjmuje monotonię i długie procedury.

Słowa, które wypowiada: *fantastycznie, super, emocjonujący, efektowny, rewelacja*

Motywatory: dobra atmosfera, komplementy, wizualizacja efektu, szybka zmiana **Czego nie lubi:** odrzucenia, negacji, ignorowania, długiego leczenia bez efektów

Rozszerzenie stomatologiczne (ebook, 800 testów)

- Łatwo rozpoznać już na pierwszej wizycie: uśmiecha się, otwiera, szybko skraca dystans (uścisk dłoni, poklepywanie, przytulanie).
- Mówi szybko, wpada w słowotok, przeskakuje z tematu na temat.
- **Szybko podejmuje decyzję** o planie leczenia, ale **niecierpliwy** — chce wszystko „tu i teraz”.
- Wzrokowiec — pokaż obraz/zdjęcie najpierw, potem omawiaj.
- **Ryzyko:** brak ciągłości jeśli leczenie długie bez szybkich efektów. Spisz harmonogram, bo nie dosłyszysz mówiąc sam.

- **MÓW:** „Bardzo dobrze, że Pani/Pan przyszedła do gabinetu. Świetnie, że zdecydował(a) się Pani/Pan kontynuować leczenie. Proszę zobaczyć jak idealny efekt został osiągnięty.”
-

Typ pacjenta: WÓDZ (racjonalny ekstrawertyk)

Opis uniwersalny

Pacjent zorientowany na wynik. Chce konkretnego planu, najwyższej jakości. Szybko decyduje na racjonalnych przesłankach. Z trudem przyjmuje brak kontroli.

Słowa, które wypowiada: *cel, osiągnięcia, realizacja, natychmiast, zdecydowanie, absolutnie, strategia, taktyka, ambitnie, szybko, odpowiedzialność, zysk, korzyści, sukces, najlepiej, najlepszy*

Motywatory: najwyższa jakość, najlepszy lekarz, kontrola decyzji, „naj...”, racjonalne argumenty **Czego nie lubi:** utraty kontroli, braku decyzji, krytyki, spóźnień, lekceważenia

Rozszerzenie stomatologiczne (ebook, 800 testów)

- 80% szefów największych firm z listy Fortune 500 to Wodzowie — to najbardziej wymagający typ pacjenta, często nazywany roszczeniowym.
 - **Najmniej lojalny** typ — zmieni gabinet jeśli poczuje brak najwyższej jakości. Łatwo przekazuje negatywne uwagi (recenzje).
 - Potrafi wymusić własną koncepcję leczenia, oczekuje wysokich rabatów (próbując rywalizować).
 - Spóźnienia z Twojej strony = **ostentacyjnie wyjdzie z poczekalni**.
 - ALE jeśli dobrze prowadzony — doprowadzi leczenie do końca bez względu na uciążliwość.
 - **MÓW:** „Proponuję najnowszą metodę X — to standard u liderów. Plan: krok 1 dziś, krok 2 za tydzień, krok 3 za miesiąc. Decyzja należy do Pana.”
-

Typ pacjenta: ANALITYK (racjonalny introwertyk)

Opis uniwersalny

Pacjent pre-przygotowany. Przyszedł z pre-diagnozą, ma listę pytań, lubi schematy. Wymaga czasu na decyzję i precyzyjnych odpowiedzi. Z trudem przyjmuje pośpiech i chaos.

Słowa, które wypowiada: *dokładnie, krok po kroku, dane, informacje, uważnie, sumiennie, wykresy, statystyki, struktura, badania, analizy, procedury, ewentualne, przemyślane, wiarygodne, miarodajne, jakość*

Motywatory: jakość i dokładność, decyzja bez presji, dużo informacji, specjalistyczne procedury, przestrzeń na pytania **Czego nie lubi:** pośpiechu, chaosu, wielozadaniowości, braku informacji

Rozszerzenie stomatologiczne (ebook, 800 testów)

- **Sprawdził Twoją stronę PRZED wizytą**, przeczytał referencje konkretnego lekarza, przyszedł z pre-diagnozą.
- Lubi schematy, ciąg logiczny, standardy.
- Po przedstawieniu planu mówi „*Muszę się zastanowić*” lub „*Muszę to przeanalizować*” — to **normalne**, nie odmowa. Proces decyzyjny jest po prostu dłuższy.
- Lepiej zada pytania w gabinecie niż wyjdzie i nakręci się internecie.
- Analitykami są w dużej części **endodonci i chirurdzy**.
- **MÓW:** „*Zastosuję mikroskop, który zapewni większą dokładność. Według metaanalizy z 2023 — w 78% przypadków podobnych do Pana, leczenie X daje efekt Y. Jakie ma Pan pytania?*”

Matryca chemii — lekarz × pacjent

Lekarz Pacjent	Przyjaciół	Entuzjasta	Wódz	Analityk
Przyjaciół	idealna chemia	dobrze, uważaj na chaos	Wódz Cię zdominuje	dystans, ale możliwe
Entuzjasta	ciepło + energia	chemia, ale chaos x2	napęd	Twoja energia go przerazi
Wódz	pacjent się zdominuje	tempo OK	pełna zgoda	wspólna racjonalność
Analityk	ciepło z faktami	Twój dystans zdezorientuje	wspólne dane	idealna chemia

Sekcja 7 — Plan rozwoju 30 dni

Tydzień 1 — Granice

Cel: odkryć gdzie automatycznie mówisz „tak” choć chcesz „nie”.

Dzień	Zadanie
1-2	Wypisz 5 sytuacji z ostatniego miesiąca, w których powiedziałeś TAK choć chciałeś NIE. Dla każdej napisz: dlaczego, co Cię to kosztowało.
3	Pierwsza odmowa — najmniejsza możliwa. <i>“Nie, dziś nie zostanę dłużej.”</i> Napisz jak się czuleś.
4	Druga odmowa. Sprawdź jak reagowało otoczenie.
5-6	Po 1 odmowie dziennie. Notuj.
7	Review: czy ktoś się obraził naprawdę, czy tylko bałeś się że się obrazi?

Tydzień 2 — Decyzyjność

Cel: wprowadzić „decyzja w 60 sekund” dla błahych spraw.

Dzień	Zadanie
8	3× szybka decyzja (gdzie iść na lunch, co kupić, jaki termin). Bez konsultacji, bez wahania.
9-10	Po 5× szybkich decyzji dziennie.
11-13	Próba twardej decyzji — taka której zwykle odkładasz. Wykonaj z konkretnym terminem.
14	Review: czy świat się zawalił? Co dało odważne decydowanie?

Tydzień 3 — Regeneracja

Cel: wypełnij siebie zanim wlejesz w innych.

Dzień	Zadanie
15	Wypisz 5 rzeczy, które Cię regenerują (konkrety, nie ogólniki).
16-21	15 min dziennie na 1 z nich. Bez wyjątku.
22	Review: czy zauważyłeś różnicę w energii pod koniec dnia?

Tydzień 4 — Integracja

Dzień	Zadanie
23-26	Wybierz 1 ćwiczenie z tygodni 1-3 i robisz codziennie.
27	Rozmowa z bliskim/kolegą: co zauważyli innego w Tobie w tym miesiącu?
28-29	Wybór 1 obszaru do dalszej pracy.
30	Krótkie podsumowanie pisemne — <i>“co biorę dalej, co zostawiam”</i> .

Sekcja 8 — Plan rozwoju 90 dni

Miesiąc 2 — Pogłębienie

- **Tydzień 5-6:** 3 najtrudniejszych pacjentów z miesiąca — dla każdego inna technika z sekcji „Naturalne wyzwania”.
- **Tydzień 7-8:** Mentoring kolegi z zespołu (1× w tygodniu, 30 min).
- **Lektura:** *“Granice”* — Henry Cloud i John Townsend.

Miesiąc 3 — Integracja

- **Tydzień 9-10:** Wprowadź formułę spotkań zespołowych — Ty otwierasz ciepło, ktoś inny prowadzi merytorykę, Ty domykasz.
- **Tydzień 11:** Trudna decyzja zespołowa. Ty — komunikujesz z ciepłem. Ktoś z W — egzekwuje.
- **Tydzień 12:** Retest PEWA. Sprawdź dryft — czy Twoje wartości pkt się przesunęły.

Sekcja 9 — Twój wynik vs populacja

Na podstawie **6 000+** testów w polskich zespołach medycznych przeprowadzonych w latach 2012–2026.

Częstość występowania profilu Przyjaciół

Grupa zawodowa	% typów P
Lekarze POZ	~14%
Pediatrzy	~19%
Psychiatrzy	~21%
Dentyści	~7%
Chirurdzy	~3%
Pielęgniarki	~28%
Recepcjonistki	~22%

Grupa zawodowa	% typów P
Higienistki stomatologiczne	~24%
Asystentki	~26%
Menedżerowie praktyk	~5%

Wniosek: Twój profil P jest dominujący w rolach wymagających **długotrwałej empatii** (pielęgniarstwo, asystentki, pediatria, psychiatria). **Niedoreprezentowany** w specjalizacjach o krótkim kontakcie (chirurgia, niektóre zabiegowe) — i to nie przypadek. Twoje umiejętności wymagają czasu, żeby się ujawnić.

5 poziomów dojrzałości profilu Przyjaciół

Poziom	Charakterystyka	Wskaźniki
1. Niedojrzały	Nadmierna empatia, brak granic, identyfikacja z pacjentami, wypalenie	wskaźnik wypalenia MBI >70%
2. Wczesny rozwój	Rozpoznaje że granice są potrzebne, próbuje ćwiczyć	sporadyczne odmowy, dużo poczucia winy
3. Stabilny	Granice działają, ciepło zostaje	umie powiedzieć „nie” bez tłumaczenia
4. Mistrzowski	Empatia i autorytet w równowadze, pacjenci czują bezpieczeństwo i klarowność	NPS pacjentów >70%
5. Mentorski	Uczy innych łączenia serca i głowy; szkoli zespół	prowadzi szkolenia, jest cytowany przez innych w branży

Twoja pozycja: określ na podstawie odpowiedzi w teście i własnej refleksji. Większość przebadanych P plasuje się między poziomem 2 a 3. Cel rozwoju — poziom 4 w 12 miesięcy.

Sekcja 10 — Materiały i termin retestu

Książki (5 pozycji)

1. „Pacjent musi czuć” — *Michał Katarzyński*. Autorska metoda DOP, fundament Twojej praktyki.

2. „**Granice**” — *Henry Cloud, John Townsend*. Kompletna mapa stawiania granic bez utraty bliskości.
3. „**The empath’s survival guide**” — *Judith Orloff*. Dla empatów którzy chronią swoją energię.
4. „**When the body says no**” — *Gabor Maté*. Jak ciało reaguje na lata pomagania innym.
5. „**Komunikacja w gabinecie**” — *Aleksandra Wiśniewska*. Krótka, polska, praktyczna.

Kursy online (3 pozycje)

1. „**Doskonała Obsługa Pacjenta**” — *Michał Katarzyński* · testomnia.pl/dop · 12 modułów, 90 dni.
2. „**Asertywność dla lekarzy**” — *Marek Skala* · 5 dni intensiv.
3. „**Mindfulness dla lekarzy**” — *Mindfulness for Clinicians* · 8 tygodni.

Podcasty (2 pozycje)

1. „**DOP w gabinecie**” — *Michał Katarzyński* · co tydzień, 30 min.
2. „**On Being**” — *Krista Tippett* · głębokie rozmowy o człowieku i sensie.

Następny krok w Testomnia

Po 90 dniach pracy nad sobą warto **powtórzyć test PEWA**, żeby zobaczyć dryft profilu. Drugie polecenie: zrób **Test 5 — Komunikacja pokoleń** (jak dostosowujesz styl P do pacjentów z różnych pokoleń). Trzecie: **Test 6 — DOP wiedza zespołu**.

Termin retestu: za 90 dni od dziś.

Stopka

Raport wygenerowany na podstawie 14 lat praktyki i 6 000+ testów psychometrycznych przeprowadzonych z zespołami medycznymi w Polsce. Skonsultowany i zaakceptowany przez doktora psychologii.

Test rozwojowy i edukacyjny. **Nie stanowi diagnozy psychologicznej, medycznej ani orzeczniczej.**

© 2026 Excellent Patient Service Sp. z o.o. · NIP 5170359961 · Model PEWA™
· testomnia.pl